Cáncer de endometrio dMMR avanzado: ¿pembrolizumab solo, sin quimioterapia, en primera línea? El ensayo KEYNOTE-C93

Slomovitz BM, Zhu J, Yin R, et al. First-line pembrolizumab versus carboplatin plus paclitaxel in participants with mismatch repair-deficient advanced or recurrent endometrial cancer (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15): interim analysis of a multicentre, open-label, randomised, active-comparator controlled, phase 3 trial. *Lancet*. 2026 (publicado en línea el 26 de octubre de 2026). doi:10.1016/S0140-6736(26)02095-7
Versión 1.0 · Revisado el 1 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?

Abre una opción sin quimioterapia

En dMMR, pembrolizumab solo superó a carboplatino con paclitaxel en supervivencia libre de progresión, con menos toxicidad. No se comparó con el estándar actual: inmunoterapia más quimioterapia.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?

Sólido en SLP; SG no significativa

Fase 3, revisión central cegada y análisis de sensibilidad concordantes. La supervivencia global no alcanzó significancia en el análisis intermedio (97 de los ~102 eventos del análisis final), con cruce masivo a inmunoterapia en el grupo control.

CUIDADO AL INTERPRETAR

Las curvas se cruzan a los 6 meses

Al inicio no hubo ventaja (75 % vs 76 % sin progresión a 6 meses) y 1 de cada 4 pacientes con pembrolizumab progresó en ese lapso (vs ~1 de cada 5 con quimioterapia). El HR de 0.57 promedia un efecto tardío.

En 30 segundos. Ensayo fase 3 abierto en 122 centros de 24 países. 299 pacientes con cáncer de endometrio avanzado o recurrente con **deficiencia del sistema de reparación de errores de apareamiento (dMMR, *mismatch repair*)**, sin tratamiento sistémico previo para enfermedad avanzada, se asignaron a **pembrolizumab 400 mg c/6 semanas** (hasta 18 ciclos) o a **carboplatino con paclitaxel** (6 ciclos). Con una mediana de ~36.5 meses desde la aleatorización hasta el corte, la supervivencia libre de progresión (SLP) mediana fue de **38.2 vs 8.4 meses** (HR 0.57; IC 95 % 0.42 a 0.79). La supervivencia global (SG) estimada a 3 años fue de 71 % vs 62 %; el HR de SG (0.77; 0.52 a 1.15) no alcanzó significancia. Los eventos adversos relacionados de grado ≥3 fueron **18 % vs 51 %**, y la puntuación de calidad de vida a 12 semanas favoreció a pembrolizumab (desenlace secundario, en diseño abierto).

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN

Riesgos no proporcionales y cruce de tratamiento: por qué un HR único engaña cuando las curvas se cruzan, cómo leer los puntos de corte de Kaplan-Meier y por qué el cruce del grupo control al tratamiento experimental diluye la diferencia en supervivencia global.

1 La pregunta clínica (PICO)

POBLACIÓN	Mujeres ≥18 años con carcinoma o carcinosarcoma de endometrio inoperable en estadio III o IV, persistente, avanzado o recurrente, con dMMR confirmada de forma central por inmunohistoquímica; ECOG 0 o 1; sin tratamiento sistémico previo, salvo quimioterapia con platino adyuvante o neoadyuvante si la recurrencia ocurrió ≥6 meses después, radioterapia previa o terapia hormonal suspendida. Mediana de edad 62 años; histología endometrioide 91 %; enfermedad recurrente 55 %; 97 % sin quimioterapia adyuvante o neoadyuvante previa.
INTERVENCIÓN	Pembrolizumab 400 mg IV cada 6 semanas, hasta 18 ciclos.
COMPARADOR	Carboplatino AUC 5 o 6 más paclitaxel 175 mg/m² IV cada 3 semanas por 6 ciclos. Al progresar, se permitía el cruce a pembrolizumab.
DESENLACES	Coprimarios: SLP por RECIST 1.1 según revisión central independiente cegada, y SG. Secundarios: respuesta objetiva, control de la enfermedad, duración de la respuesta, SLP2 (desde la aleatorización hasta la progresión con el siguiente tratamiento o la muerte), calidad de vida (EORTC QLQ-C30) y seguridad.

2 Diseño

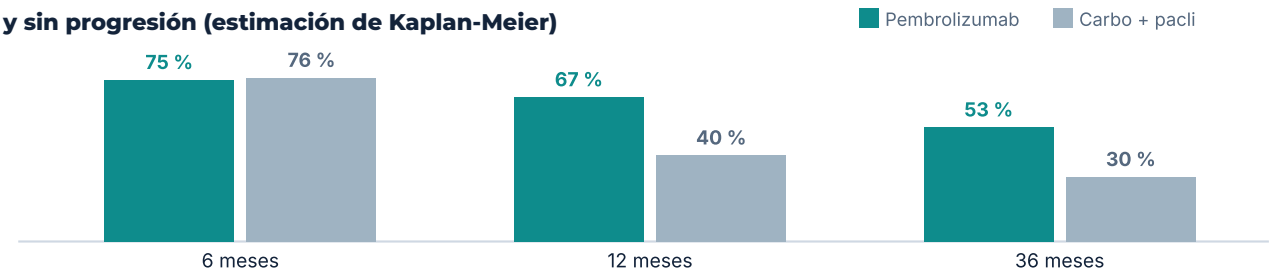
TIPO	Ensayo fase 3, multicéntrico, aleatorizado 1:1, abierto, con comparador activo (febrero de 2022 a diciembre de 2023). Registro NCT05173987; sigue en curso.
ANÁLISIS	Análisis intermedio preespecificado (corte: 24 de abril de 2026), que fue el análisis final de SLP y el intermedio de SG. Mediana desde la aleatorización hasta el corte: 36.7 y 36.4 meses. Se observaron 163 de los 180 eventos de SLP planeados y 97 de los 102 eventos de SG del análisis final.
SUPUESTO DE DISEÑO	Los autores asumieron **HR de 1.0 durante los primeros ~4.5 meses y de 0.33 después**: anticiparon un efecto tardío de la inmunoterapia.
FINANCIAMIENTO	Merck Sharp & Dohme, fabricante de pembrolizumab, que participó en el diseño, el análisis, la interpretación y la redacción.

3 Resultados

DESENLACE	PEMBROLIZUMAB	CARBO + PACLI	EFECTO (IC 95 %)
SLP mediana (coprimario)	**38.2 meses**	**8.4 meses**	**HR 0.57 (0.42 a 0.79)**; p = 0.0002
Sin progresión a 6 / 12 / 36 meses	75 % / 67 % / 53 %	76 % / 40 % / 30 %	—
Progresión en los primeros 6 meses	36 (24 %)	28 (19 %)	—
SG (coprimario, intermedio)	43 muertes (29 %)	54 muertes (36 %)	**HR 0.77 (0.52 a 1.15)**; p = 0.10, no significativo
SG estimada a 3 años	71 %	62 %	—
Respuesta objetiva / completa*	64 % / 34 %	62 % / 26 %	No se probó formalmente
Respuesta que duró ≥36 meses†	71 %	40 %	—
SLP2 (hasta la progresión con el siguiente tratamiento o la muerte)	Mediana no alcanzada en ambos		HR 0.63 (0.43 a 0.91)
Calidad de vida global a 12 semanas (secundario)	+5.06 puntos	−1.96 puntos	Diferencia 7.02 (2.54 a 11.50)
EA relacionados de grado ≥3	27 (18 %)	73 (51 %)	—
Suspensión por EA relacionado	14 (9 %)	21 (15 %)	—
Muertes relacionadas con el tratamiento	2 (insuficiencia hepática, meningitis bacteriana)	1 (tromboembolia pulmonar)	—
EA inmunomediados o reacciones a la infusión	62 (42 %); grado ≥3: 7 %	25 (17 %); grado ≥3: 3 %	Grupo pembrolizumab: hipotiroidismo 24 %, hipertiroidismo 11 %

*En pacientes con enfermedad medible (145 por grupo). †Estimación de Kaplan-Meier entre las respondedoras confirmadas (93 vs 90). EA: eventos adversos. Duración mediana del tratamiento: 23.4 vs 3.5 meses.

Vivas y sin progresión (estimación de Kaplan-Meier)



Elaborado por Medicina en Resumen con las estimaciones de SLP reportadas en el artículo; no reproduce figuras originales.

4 Cómo leer estos resultados

- **El beneficio es tardío.** DATO DEL ARTÍCULO Las curvas de SLP se cruzaron cerca de los 6 meses y luego se separaron a favor de pembrolizumab. Una prueba post hoc confirmó riesgos no proporcionales; el tiempo medio restringido sin progresión favoreció a pembrolizumab desde los 12 meses. Los autores sugieren que podría reflejar el efecto retardado de la inmunoterapia y que pudo haber seudoprogresión en algunas pacientes: 19 % siguió con pembrolizumab tras la progresión.
- **SG no significativa no es ausencia de efecto, pero tampoco demuestra beneficio.** DATO DEL ARTÍCULO El 85 % de las pacientes del grupo control con progresión verificada de forma central (75 de 88) recibió pembrolizumab por cruce o algún inhibidor de PD-1/PD-L1 fuera del estudio; según los autores, esto puede haber atenuado la diferencia. INTERPRETACIÓN El ensayo compara, en la práctica, "inmunoterapia primero" frente a "quimioterapia primero e inmunoterapia después". El análisis final de SG se hará con ~102 eventos, solo ~5 más que ahora.
- **Respuesta parecida, duración muy distinta.** La proporción de respuesta fue similar (64 % vs 62 %), pero la respuesta completa (34 % vs 26 %) y la duración de la respuesta favorecieron a pembrolizumab. Son datos descriptivos: la respuesta no se probó formalmente por la jerarquía estadística.
- **El comparador ya no es el estándar.** DATO DEL ARTÍCULO Hoy se prefiere inmunoterapia más quimioterapia. En los subgrupos dMMR de esos ensayos, la reducción del riesgo de progresión o muerte fue de 58 % a 72 % (evaluada por el investigador, con seguimiento mediano de 12 a 26.7 meses), frente a 43 % aquí (revisión central, ~36 meses). Los autores señalan que, después de los 6 meses, la separación de las curvas fue similar a la de esos ensayos, y advierten que comparar entre ensayos es arriesgado por diferencias de diseño, población y seguimiento.
- **Subgrupos preespecificados, sin pruebas formales.** DATO DEL ARTÍCULO El HR de SLP fue 0.45 (0.29 a 0.70) en enfermedad recurrente y 0.77 (0.49 a 1.21) en enfermedad avanzada de nuevo diagnóstico; en SG, 0.52 (0.30 a 0.93) y 1.18 (0.66 a 2.09), respectivamente. INTERPRETACIÓN Genera la hipótesis de que el beneficio de la monoterapia es menor en la enfermedad recién diagnosticada; no permite concluirlo.

- **Toxicidad: menos, pero distinta.** Mucho menos alopecia, anemia, disminución de neutrófilos, náusea y neuropatía. Más eventos inmunomediados, sobre todo tiroideos. **DATO DEL ARTÍCULO** La exposición a pembrolizumab fue mucho más larga (23.4 vs 3.5 meses), lo que complica comparar porcentajes crudos.

CONCEPTO CLAVE · CUANDO LAS CURVAS SE CRUZAN, EL HR ES UN PROMEDIO

INTERPRETACIÓN El HR resume el efecto en un solo número y asume que es constante en el tiempo (riesgos proporcionales). Aquí no lo fue: sin diferencia en los primeros 6 meses (incluso con algo más de progresión temprana con pembrolizumab) y mucho beneficio después. El HR de 0.57 mezcla ambas fases. Por eso conviene leer las estimaciones en puntos de corte (6, 12 y 36 meses) y el tiempo medio restringido sin evento. En la clínica, la pregunta deja de ser "¿funciona?" y pasa a ser "¿qué paciente puede tolerar no tener beneficio durante los primeros meses?".

5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Evaluación de la SLP	Revisión central independiente cegada; concordante con la evaluación del investigador y con análisis de sensibilidad y post hoc.	Confirmado
Selección molecular	dMMR confirmada de forma central antes de la aleatorización.	Confirmado
Comparador	Carboplatino con paclitaxel era el estándar al iniciar el estudio; hoy lo es la combinación con inmunoterapia.	Reconocido por los autores
SG inmadura y con cruce	Análisis intermedio; el 40 % del grupo control recibió pembrolizumab por cruce y otro 18 %, algún inhibidor de PD-1/PD-L1 fuera del estudio.	Reconocido por los autores
Diseño abierto	Puede influir en la calidad de vida reportada, analizada con supuestos de datos faltantes al azar; la mayoría de esos análisis fueron exploratorios.	Reconocido por los autores
Estratificación modificada	Dos de los tres factores de estratificación se eliminaron de los análisis (uno se añadió tarde por enmienda).	Dato del artículo
Patrocinio	El fabricante participó en el diseño, el análisis y la redacción.	Dato del artículo
Aplicabilidad	Solo ECOG 0 o 1; 91 % endometrioide; pocas pacientes negras, lo que los autores relacionan con la epidemiología de dMMR.	Reconocido por los autores

Pregunta de repaso: mujer de 70 años con cáncer de endometrio endometrioide recurrente, dMMR, ECOG 1, con neuropatía diabética previa, que no quiere quimioterapia. ¿Qué aporta KEYNOTE-C93?
Respuesta. Respalda pembrolizumab solo como opción sin quimioterapia: frente a carboplatino con paclitaxel prolongó la SLP (mediana 38.2 vs 8.4 meses), con menos toxicidad grave y sin la neuropatía del paclitaxel. Advierte que no hay ventaja en los primeros meses y que cerca de 1 de cada 4 progresó antes de los 6 meses. Además, no se comparó con la combinación de inmunoterapia y quimioterapia, que es la opción preferida en pacientes que la toleran. Vigila la función tiroidea y los eventos inmunomediados.

¿Qué aprendí de medicina?

- dMMR avanzado: pembrolizumab solo supera a carboplatino con paclitaxel en SLP (38.2 vs 8.4 meses).
- Menos toxicidad grave (18 % vs 51 %); mejor puntuación de calidad de vida a 12 semanas (secundario, diseño abierto).
- Sin beneficio en los primeros 6 meses; SG aún no significativa.
- No se comparó con inmunoterapia más quimioterapia, el estándar actual.

¿Qué aprendí de investigación?

- Curvas que se cruzan: el HR es un promedio.
- Lee los puntos de corte y el tiempo medio restringido.
- El cruce del grupo control puede diluir la diferencia en SG.
- Un comparador superado limita la aplicabilidad.

6 Referencias

1. Slomovitz BM, Zhu J, Yin R, et al. First-line pembrolizumab versus carboplatin plus paclitaxel in participants with mismatch repair-deficient advanced or recurrent endometrial cancer (KEYNOTE-C93/GOG-3064/ENGOT-en15): interim analysis of a multicentre, open-label, randomised, active-comparator controlled, phase 3 trial. Lancet. 2026 (publicado en línea el 26 de octubre de 2026). doi:10.1016/S0140-6736(26)02095-7

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. **DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.